

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Relaciones Médico-Paciente (adaptación española del Patient-Doctor Relationship Questionnaire, PDRQ) (CREM-P)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual
— adaptación española de 13 ítems, distinta en extensión del PDRQ-9 internacional de 9
ítems (ver advertencia)

1. Identificación

Familia / sigla	CREM-P
Nombre completo	Cuestionario de Relaciones Médico-Paciente (CREM-P) — adaptación española del Patient-Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ)
Versión / edición	Versión española final de 13 ítems (Mingote Adán et al., 2009), derivada de la versión original de 15 ítems de Van der Feltz-Cornelis et al. (2004).
Idioma	Español.
Autores (original / adaptación española)	Van der Feltz-Cornelis CM, Van Oppen P, Van Marwijk HWJ, De Beurs E, Van Dyck R (original). Adaptación española: Mingote Adán JC, Moreno Jiménez B, Rodríguez Carvajal R, Gálvez Herrer M, Ruiz López P.
Año (original / adaptación española)	2004 (original, PDRQ-9); 2009 (adaptación española, CREM-P).
Tiempo estimado	no verificado

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Relación paciente-profesional; comunicación; confianza; alianza terapéutica; medicina conductual.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: calidad de la relación médico-paciente percibida por el paciente, en dimensiones de comunicación, comprensión, confianza, dedicación, accesibilidad y satisfacción con el trato y el tratamiento recibido.

Finalidad: cuantificar de forma breve la percepción del paciente sobre la calidad de su relación con el médico tratante, para investigación (p. ej. asociación con adherencia, continuidad del cuidado) y para uso clínico/formativo (retroalimentación a profesionales, programas de formación en comunicación).

Usos apropiados:

- Investigación sobre la calidad de la relación médico-paciente y su asociación con adherencia terapéutica, satisfacción o continuidad del cuidado.
- Uso como medida de análisis cualitativo ítem a ítem en la práctica diaria, o en programas de formación y formación continuada de personal médico.
- Complemento a otros instrumentos de este acervo relacionados con adherencia (MGL/MMAS-4) dentro de una evaluación de medicina conductual.

Usos NO apropiados:

- Evaluación de la relación desde la perspectiva del profesional (el instrumento es unilateral, centrado exclusivamente en la percepción del paciente).
- Diagnóstico de mala praxis o de negligencia profesional; es una medida de percepción subjetiva de calidad relacional, no una auditoría clínica.
- Comparación directa cifra a cifra con estudios que usan el PDRQ-9 internacional de 9 ítems sin ajustar por la diferencia de extensión (ver advertencia sobre 13 vs. 9 ítems).

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Pacientes adultos en seguimiento médico continuado (validado originalmente en pacientes de Medicina Interna, España, edad media 61 años).
Contexto de aplicación	Atención primaria, medicina interna, cualquier especialidad con seguimiento longitudinal del paciente.
Informante	Autoinforme del paciente.

Modalidad de administración	Papel y lápiz; individual, autoadministrado y anónimo en el estudio de validación.
------------------------------------	--

5. Estructura y administración

Número de ítems	13
Periodo temporal de referencia	no verificado
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (1 a 5)
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 5 minutos, dada su brevedad).

6. Dimensiones y puntuaciones

El análisis factorial de la validación española (N=188) mostró una solución de dos factores explicando el 63.88% de la varianza: un factor principal con 14 de los 15 ítems originales (autovalor 8.53, 56.88% de varianza) y un segundo factor formado exclusivamente por el ítem eliminado 'Siento que me cuesta entenderme con mi médico'. Tras eliminar este ítem y otro de baja discriminación factorial ('Mis síntomas probablemente desaparecerán'), los autores recomiendan trabajar con un único indicador global de 13 ítems (no hay subescalas en la versión final).

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma o media de los 13 ítems; mayor puntaje = mejor percepción de la relación médico-paciente.
Ítems invertidos	No se identifican ítems inversos; los 13 ítems finales puntúan en el mismo sentido.
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	Rango teórico 13-65 (suma) o 1-5 (media). No se reportan puntos de corte clínicos de consenso en el artículo original; datos descriptivos del índice global en la muestra de validación (N=178): media 3.617 (escala 1-5), DE 0.740.

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Mingote Adán JC, Moreno Jiménez B, Rodríguez Carvajal R, Gálvez Herrero M, Ruiz López P (2009). Actas Esp Psiquiatr, 37(2), 94-100. Muestra: 188 pacientes de Medicina Interna, Hospital Universitario 12 de Octubre,

Madrid (edad media 61 años, 50.3% hombres). Consistencia interna de la versión final de 13 ítems: alfa de Cronbach = 0.956 (superior al alfa de 0.94 del estudio original holandés de 9 ítems). Validez de criterio: asociación significativa entre mayor tiempo de continuidad con el mismo médico y mejor puntuación en el CREM-P (odds ratio 8.577 para >5 años vs. ≤1 año). Validez de contenido: equivalencia estadística con el cuestionario original mediante contraste de medias ($t=-1.558$, no significativo; tamaño del efecto $d=0.168$), sugiriendo que ambos cuestionarios miden el mismo constructo pese a la diferencia de extensión.

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación y validación formal en población española (Mingote et al., 2009, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid), con traducción directa e inversa. No se verificó en esta sesión una adaptación normativa específica para países de Latinoamérica; existe también una validación en población mexicana con diabetes mellitus tipo 2 usando una traducción propia de 9 ítems (Fernández Castillo et al., 2021, Psicumex) — instrumento distinto (9 ítems, sin nombre CREM-P) del aquí documentado (13 ítems), no verificado si comparten exactamente la misma traducción de cada ítem.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- El CREM-P de 13 ítems NO es idéntico en extensión al PDRQ-9 internacional de 9 ítems: la reducción de 15 a 13 ítems en la muestra española eliminó ítems distintos de los eliminados en la validación holandesa original de 9 ítems (ver advertencia detallada en Fuente_y_uso.md).
- Mide exclusivamente la percepción del paciente; no incorpora la perspectiva del profesional ni observación conductual directa de la consulta.
- Posible sesgo de deseabilidad social, parcialmente mitigado en el estudio de validación mediante administración anónima y voluntaria.
- No sustituye evaluación de mala praxis, competencia profesional ni auditoría clínica de calidad asistencial.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El artículo de validación española (Mingote et al., 2009) fue publicado en Actas Españolas de Psiquiatría, revista con sistema de publicación abierto (Open Journal Systems), con PDF descargable directamente sin barrera de

pago detectada durante la verificación. Uso previsto: académico/asistencial no comercial, citando la fuente. El Protocolo.pdf de este acervo reproduce literalmente los 13 ítems de la Tabla 7 del artículo (reconstrucción textual verificada, no el artículo completo de 7 páginas ni el binario original).

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Van der Feltz-Cornelis CM, Van Oppen P, Van Marwijk HWJ, De Beurs E, Van Dyck R (2004). A patient-doctor relationship questionnaire (PDRQ-9) in primary care: development and psychometric evaluation. *General Hospital Psychiatry*, 26, 115-120.

Mingote Adán JC, Moreno Jiménez B, Rodríguez Carvajal R, Gálvez Herrero M, Ruiz López P (2009). Validación psicométrica de la versión española del Cuestionario de Relaciones Médico-Paciente (CREM-P). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 37(2), 94-100.

<https://actaspsiquiatria.es/index.php/actas/article/view/834>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 13 ítems completos + reglas de puntuación + notas sobre el proceso de adaptación). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0